Клинические рекомендации

Отит средний острый

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H65.0** — Острый средний серозный отит **H65.1** — Другие острые негнойные средние отиты **H66.0** — Острый гнойный средний отит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/314_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Стадии 4

2.3 Степень тяжести 4

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Отоскопия 5

3.3 Пневматическая отоскопия 5

3.4 Тональная аудиометрия 5

3.5 Общий (клинический) анализ крови 6

3.6 Прокальцитонин крови 6

3.7 Микробиологическое исследование отделяемого 6

3.8 Компьютерная томография височных костей 6

4. Лечение 7

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия 7

4.2 Показания к антибактериальной терапии 7

4.3 Выбор антибактериального препарата 7

4.4 Суточные дозы 8

4.5 Местная и вспомогательная терапия 9

4.6 Хирургическое лечение 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9

6. Источник и актуальность 10

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Острый средний отит (ОСО) является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу. Заболевание проявляется болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением из уха.
- Диагноз острого среднего отита:

  Обязательные критерии (все три одновременно)

  1. острое начало заболевания;
  2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
  3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

  Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.
- Показания к системной антибактериальной терапии:
  1. возраст **до 2 лет**: во всех случаях при клинических признаках отита;
  2. гнойная форма независимо от возраста;
  3. сохранение симптомов **более 72 часов**;
  4. рецидивирующее течение;
  5. отягощающая сопутствующая патология;
  6. невозможность повторного осмотра пациента.
- Препаратом первой линии является амоксициллин. При отсутствии эффекта **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим. Курс составляет **7–10 дней**.
- Для обезболивания используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол; ушные капли с лидокаином и феназоном допустимы только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.
- Показания к экстренной госпитализации:
  1. тяжёлое течение;
  2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
  3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.
- **Через 3–4 недели** пациента повторно осматривают с пневмоотоскопией или тимпанометрией, чтобы своевременно выявить экссудативный средний отит.

2. Клиническая картина и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определения

Острый средний отит является воспалительным процессом, охватывающим все три отдела среднего уха (барабанную полость, клетки сосцевидного отростка и слуховую трубу) и проявляющимся одним или несколькими симптомами: болью в ухе, повышением температуры тела, снижением слуха, в ряде случаев гноетечением. Поражается только слизистая оболочка.

Рецидивирующим считается отит при 3 и более эпизодах за 6 месяцев или 4 и более эпизодах за 12 месяцев.

Затянувшимся считается отит, при котором симптомы воспаления среднего уха сохраняются в течение 3–12 месяцев после одного или двух курсов антибактериальной терапии.

У детей возможны возбуждение, раздражительность, рвота и диарея. Заболевание, как правило, длится не более трёх недель.

2.2 Стадии

1. острый евстахеит;
2. острое катаральное воспаление;
3. доперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
4. постперфоративная стадия острого гнойного воспаления;
5. репаративная стадия.

Отоскопическая картина каждой стадии приведена в разделе «Диагностика».

2.3 Степень тяжести

Лёгкое течение	Тяжёлое течение
Осложнения отсутствуют	Интратемпоральные или внутричерепные осложнения
Выбухание барабанной перепонки отсутствует	Выраженное выбухание барабанной перепонки
Непродолжительная боль в ухе, хорошо купируется лекарственными средствами	Выраженный болевой синдром (у детей раннего возраста проявляется изменением поведения), плохо купируется или не купируется лекарственными средствами
Общее состояние не изменено: сон, аппетит и активность не нарушены	Общее состояние изменено
Нормальная температура тела или субфебрилитет не более 3 дней	Субфебрилитет более 3 дней или температура тела выше 38,0 °C

2.4 Клиническая картина

Дети старше 2 лет

1. остро возникшая боль в ухе;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, выбухание, снижение подвижности при пневмоотоскопии;
3. оторея в постперфоративной стадии.

Дети раннего возраста

1. выбухание барабанной перепонки;
2. изменения поведения: беспокойство, отказ от еды, ребёнок теребит и трёт ухо.

Взрослые пациенты чаще предъявляют жалобы на заложенность уха, аутофонию и шум в ухе.

Снижение слуха носит кондуктивный характер; сенсоневральный компонент присоединяется редко.

2.5 Возбудитель и выбор антибактериального препарата

Возбудителя в ряде случаев можно предположить по клинической картине. При сочетании отита с конъюнктивитом наиболее вероятным возбудителем является H. influenzae. Стремительное начало с лихорадкой, спонтанной перфорацией и симптомами со стороны дыхательных путей характерно для S. pyogenes, нарастающая боль, лихорадка и спонтанная перфорация характерны для S. pneumoniae.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии (все три одновременно)

1. острое начало заболевания;
2. воспалительные изменения барабанной перепонки: гиперемия, инфильтрация;
3. признаки выпота в барабанной полости: выбухание барабанной перепонки или снижение её подвижности при пневмоотоскопии или тимпанометрии.

Диагноз подтверждает также внезапно возникшая оторея при исключённом наружном отите.

3.2 Отоскопия

Показания

1. все пациенты с острым средним отитом: первичный осмотр оториноларинголога при обращении и при госпитализации.

Диагностические признаки по стадиям

1. В стадии острого катарального воспаления барабанная перепонка гиперемирована, утолщена, опознавательные знаки определяются с трудом или не определяются.
2. В стадии острого гнойного воспаления боль в ухе резко усиливается, температура тела достигает фебрильных значений; барабанная перепонка ярко гиперемирована, выбухает, опознавательные знаки не определяются, возможна перфорация.
3. В постперфоративной стадии через перфорацию барабанной перепонки в наружный слуховой проход поступает гнойное отделяемое.
4. В репаративной стадии жалобы практически отсутствуют, цвет и толщина барабанной перепонки восстанавливаются, перфорация в большинстве случаев закрывается рубцом, однако восстановление слизистой оболочки среднего уха ещё не наступило.

3.3 Пневматическая отоскопия

Показания

1. отсутствие реактивных изменений барабанной перепонки: оценка её подвижности.

Диагностические признаки

1. снижение подвижности (податливости) барабанной перепонки указывает на воспалительный выпот в барабанной полости.

3.4 Тональная аудиометрия

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. рецидивирующий отит;
3. исключение нейросенсорной тугоухости.

3.5 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. все пациенты с острым средним отитом.

Диагностические признаки

1. уровень лейкоцитоза позволяет оценить вероятность бактериальной природы воспаления (пороговые значения в таблице ниже).

3.6 Прокальцитонин крови

Показания

1. подозрение на тяжёлое течение;
2. сложные диагностические случаи: подтверждение бактериальной природы отита.

Маркеры бактериального воспаления

Показатель	Катаральный отит	Гнойный отит
Лейкоциты <10 / 10–15 / >15 ×10^9/л	50% / 38% / 12%	12% / 29% / 59%
СРБ <15 / 15–60 / ≥60 мг/л	33% / 50% / 17%	14% / 36% / 50%
ПКТ <0,5 / 0,5–2 / 2–10 нг/мл	58% / 38% / 4%	4% / 32% / 64%

Пороговые значения для гнойного отита: лейкоциты >15×10^9/л (ППР 85%, ПОР 64%), С-реактивный белок (СРБ) >30 мг/л (ППР 79%, ПОР 52%), прокальцитонин (ПКТ) >2 нг/мл (ППР 94%, ПОР 74%). Таблица в PDF представлена изображением; значения перенесены вручную и сверены по изображению страницы 13.

3.7 Микробиологическое исследование отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. парацентез или отделяемое из барабанной полости у пациентов в стационаре с тяжёлым и рецидивирующим течением.

Забор материала

1. отделяемое из барабанной полости забирают сухим стерильным ватным тампоном;
2. материал с соблюдением асептики помещают в пробирку с транспортной питательной средой;
3. оптимальное время доставки в лабораторию **40 минут**.

3.8 Компьютерная томография височных костей

Показания

1. затяжное течение (**более 10 дней**);
2. выраженная стойкая отрицательная динамика;
3. подозрение на мастоидит или внутричерепные осложнения.

Если КТ выполнить невозможно, по тем же показаниям проводят рентгенографию височных костей в проекциях по Шюллеру и Майеру.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Обезболивающая и жаропонижающая терапия

При болевом синдроме и лихорадке применяют НПВП или парацетамол разово:

1. при боли в ухе;
2. при температуре тела **выше 38,5 °C**;
3. при фебрильных судорогах в анамнезе уже **при 38,0 °C**.

Детям до 6 лет допустимо назначение только парацетамола (до 60 мг/кг в сутки, 10–15 мг/кг на приём) или ибупрофена (до 30 мг/кг в сутки, 8–10 мг/кг на приём).

Местное обезболивание обеспечивают ушные капли с лидокаином и феназоном; их применение допустимо только при отсутствии перфорации барабанной перепонки.

4.2 Показания к антибактериальной терапии

Системную антибактериальную терапию назначают при наличии хотя бы одного из показаний:

Показание	Пояснение
Возраст до 2 лет	Во всех случаях при наличии клинических признаков ОСО
Гнойная форма независимо от возраста	Перфорация барабанной перепонки с гнойным отделяемым; при отсутствии перфорации болевой синдром, не купируемый анальгетиками, в сочетании с выраженной гиперемией, отсутствием опознавательных знаков и выбуханием барабанной перепонки
Сохранение симптомов более 72 часов независимо от возраста	Боль, лихорадка или интоксикация при отоскопических признаках ОСО в течение 72 часов и более от начала заболевания
Рецидивирующее течение	3 и более эпизода за 6 месяцев или 4 и более за год
Сопутствующая патология	Сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз, синдромы цилиарной дискинезии, синдром Дауна, врождённые аномалии твёрдого и мягкого нёба
Невозможность повторного осмотра	Отсутствует возможность контрольного осмотра с отоскопией врачом-оториноларингологом или врачом общей практики

4.3 Выбор антибактериального препарата

Препаратом первой линии является амоксициллин при условии, что пациент не принимал его в течение последних 30 дней, а гнойный конъюнктивит и непереносимость аминопенициллинов отсутствуют.

Препаратами второй линии являются защищённые пенициллины и цефалоспорины III поколения. При отсутствии эффекта от амоксициллина **в течение 3 дней** его заменяют на амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим.

При затянувшемся и рецидивирующем отите стартовыми препаратами являются амоксициллин с клавулановой кислотой или цефиксим внутрь.

Макролиды у детей относятся к препаратам третьей линии; их применение оправдано только при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов, поскольку устойчивость пневмококка к ним превышает 40%.

При лёгкой непереносимости пенициллинов альтернативой служат цефалоспорины III поколения: в амбулаторных условиях цефиксим, в стационаре при необходимости цефтриаксон парентерально.

Продолжительность курса составляет **7–10 дней**. Более длительные курсы необходимы:

1. детям до 2 лет;
2. пациентам с отореей;
3. пациентам с сопутствующими заболеваниями;
4. при затянувшемся и рецидивирующем отите: как правило, **не менее 14 дней**.

Антибактериальную терапию не прекращают до купирования отореи.

Тетрациклины, линкозамиды, аминогликозиды и ко-тримоксазол не рекомендуются в связи с низкой активностью в отношении пневмококка и гемофильной палочки и высокой частотой нежелательных явлений.

В постперфоративной стадии системная антибактериальная терапия продолжается.

4.4 Суточные дозы

Препарат	Взрослые	Дети
Препарат выбора		
Амоксициллин (независимо от приёма пищи)	0,5 г 3 раза в сутки без факторов риска[1]; 1,0 г 3 раза в сутки при факторах риска[2]	50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма[1]
Альтернативные препараты		
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[3] (в начале приёма пищи)	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки	40–45 мг/кг в сутки в 2–3 приёма
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в[4]	3,6 г в сутки в 3 введения	90 мг/кг в сутки в 3 введения (при массе тела 4–40 кг); 60 мг/кг в сутки (при массе тела менее 4 кг)
Ампициллин + сульбактам в/в[3]	1,5–3 г в сутки в 4 введения	150–300 мг/кг в сутки в 3–4 введения
Цефтриаксон[4]	2,0–4,0 г в сутки в 1 введение	50–80 мг/кг в сутки в 1 введение
Аллергия на пенициллины (не анафилактическая)		
Цефуроксим (непосредственно после приёма пищи)	500 мг в сутки в 2 приёма (так в таблице КР)	до 3 лет: 30 мг/кг в сутки в 2 приёма; старше 3 лет: 500 мг в сутки в 2 приёма
Цефиксим	400 мг в сутки в 1 приём	8 мг/кг в сутки в 1 приём
Аллергия на пенициллины и цефалоспорины		
Кларитромицин внутрь (показание «острый средний отит» зарегистрировано только для гранул для приготовления суспензии 125 и 250 мг/5 мл)	1000 мг в сутки в 2 приёма	15 мг/кг в сутки в 2 приёма

[1] [2] Без факторов риска / при факторах риска устойчивости пневмококка: приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца; дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения; проживание в «закрытых» учреждениях. [3] Факторы риска продукции β-лактамаз: сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит), иммуносупрессия, неэффективность терапии амоксициллином. [4] При высоком риске осложнений.

> В тексте рекомендации имеется расхождение. В комментарии к рекомендации об амоксициллине стандартная доза для детей составляет 45–60 мг/кг в сутки, а при высоком риске устойчивости пневмококка 80–90 мг/кг в сутки, тогда как в таблице 4 для детей указано 50–60 мг/кг в сутки.

У детей до 3 лет амоксициллин применяют только в форме суспензии или диспергируемых таблеток. Амоксициллин с клавулановой кислотой и цефиксим в таблетках и капсулах разрешены к применению с 12 лет; для детей младше 12 лет с массой тела менее 40 кг предназначены гранулы, порошок для приготовления суспензии или диспергируемые таблетки.

4.5 Местная и вспомогательная терапия

При перфорации барабанной перепонки купирование отореи ускоряют ушные капли на основе фторхинолонов или дексаметазона в комбинации с противомикробными средствами. Капли, содержащие аминогликозиды, и спиртосодержащие капли противопоказаны в связи с ототоксическим действием.

Ушные капли с норфлоксацином разрешены детям старше 1 года, с ципрофлоксацином с 15 лет. Капли с офлоксацином и дексаметазоном в комбинации с противомикробными средствами применяются у детей старше 1 года при остром гнойном отите и установленной тимпаностомической трубке.

Сосудосуживающие капли в нос используют во всех стадиях для восстановления проходимости слуховой трубы на срок не более 5–7 дней. Применение нафазолина не рекомендуется.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет). До года допустимы только капли, после года по возможности переходят на дозированный назальный спрей.

Детям рекомендуется орошение полости носа изотоническим раствором морской воды 1–2 раза в день. У детей дошкольного возраста от промывания полости носа большими объёмами растворов следует воздержаться, поскольку это повышает риск развития отита.

Муколитические препараты применяют у детей старше 2 лет. Перед назначением следует свериться с зарегистрированными показаниями в инструкции, поскольку не каждый муколитик, эффективный при патологии бронхов, пригоден для лечения отита.

4.6 Хирургическое лечение

Показания к парацентезу:

1. выраженная клиническая симптоматика и выбухание барабанной перепонки без перфорации;
2. болевой синдром, не купируемый НПВП;
3. отсутствие улучшения **через 48–72 часа** антибактериальной терапии.

Во всех сомнительных случаях решение принимают в пользу парацентеза.

Внутривисочные или внутричерепные осложнения требуют экстренной антромастоидотомии.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

разделы 4–6 текста КР

Через 3–4 недели необходим повторный осмотр оториноларингологом с пневмоотоскопией или тимпанометрией для исключения экссудативного среднего отита.

Жалобы на снижение слуха после перенесённого отита служат поводом для консультации сурдолога-оториноларинголога.

В репаративной стадии проводятся продувание слуховых труб и пневмомассаж барабанных перепонок. Восстановление аэрации подтверждается объективными методами, в том числе тимпанометрией.

Консультация физиотерапевта рекомендуется в репаративной стадии.

Всем детям показана вакцинация против пневмококковой инфекции в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

При рецидивирующем отите в плановом порядке выполняется шунтирование барабанной полости (тимпаностомия).

Показания к экстренной госпитализации:

1. тяжёлое течение;
2. отсутствие положительной динамики при лёгком течении на фоне адекватной терапии **в течение 3–5 дней**;
3. прогрессирующее ухудшение состояния в любые сроки.

Пациента выписывают при стабильно удовлетворительном состоянии **не менее 3 дней**.

Более тяжёлое течение и высокий риск осложнений отмечаются у пациентов с иммунодефицитом и сахарным диабетом. Риск развития отита повышен у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), аллергическим ринитом, а также у курильщиков, в том числе пассивных.

---

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Отит средний острый»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	314_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Детская доза амоксициллина в комментарии к рекомендации составляет 45–60 мг/кг/сут («стандартная») и 80–90 мг/кг/сут (при высоком риске устойчивости пневмококка), тогда как в таблице 4 указано 50–60 мг/кг/сут.
- Для цефуроксима у взрослых в таблице 4 указано «500 мг/сут в 2 приёма»; дозу следует сверить с инструкцией в ГРЛС.
- Для ушных капель с офлоксацином в одном месте указан код АТХ S01AX13 (код ципрофлоксацина), тогда как выше по тексту для офлоксацина приведён код S01AX11.
- Таблица 2 (маркеры бактериального воспаления) в PDF представлена изображением; её значения перенесены вручную.
- Ушные капли с норфлоксацином в данной рекомендации разрешены детям старше 1 года, в КР «Наружные отиты» (663_2) с 15 лет; возрастное ограничение следует сверить с инструкцией в ГРЛС.